

TEMA 10.4 • REUMATOLOGÍA

Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Diagnóstico

PERFIL EUNACOM 1.04.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El enfrentamiento de una **monoartritis aguda** (inflamación de una sola articulación de inicio brusco) es un desafío clínico mayor, ya que entre sus causas se encuentran patologías que pueden comprometer la extremidad o la vida del paciente en pocas horas.

Etiología de la Monoartritis Aguda

Existen múltiples causas, pero para efectos del examen y la práctica clínica, debemos priorizar las más graves y las más frecuentes.

- **Artritis Séptica:** Es la causa más grave. Existe riesgo de destrucción articular permanente en menos de 24-48 horas y riesgo de sepsis sistémica y muerte. Es la causa más frecuente en **niños**.
- **Artritis por Cristales:** Es la causa más frecuente en **adultos**.
- **Gota:** Por cristales de urato monosódico.
- **Condrocálcinosis (Pseudogota):** Por cristales de pirofosfato de calcio; muy frecuente en adultos mayores.
- **Monoartritis Inflamatorias No Infecciosas:**
- **Artritis Reumatoide** (puede debutar como monoartritis antes de hacerse poliarticular).
- **Artritis Reactiva.**
- *Espondiloartropatías.*
- **Causas No Inflamatorias:**
- **Osteoartritis** (Artrosis): Puede cursar con derrames articulares agudos.
- *Hemartrosis (por trauma o coagulopatías).*
- Tumores o metástasis óseas.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el **adulto mayor**, la causa más frecuente de monoartritis aguda de rodilla es la **condrocálcinosis**. En el **niño**, siempre se debe sospechar primero una **artritis séptica**.

Diagnóstico: La Artrocentesis

El examen de elección y el más importante es la **punción y estudio del líquido articular (artrocentesis)**. Este procedimiento permite diferenciar si el líquido es inflamatorio, infeccioso o mecánico.

Análisis del Líquido Sinovial

TABLA 10.4.1: PARÁMETRO VS NORMAL / NO INFLAMATORIO (ARTROSIS)

PARÁMETRO	NORMAL / NO INFLAMATORIO (ARTROSIS)	INFLAMATORIO (CRISTALES / AR)	INFECCIOSO (ARTRITIS SÉPTICA)
Leucocitos (cél/mm³)	< 1.000 - 2.000	2.000 - 50.000 (a veces >50k)	> 50.000 - 100.000
PMN (%)	< 25%	> 50%	> 75 - 90%
Aspecto	Transparente / Amarillo claro	Turbio / Opaco	Purulento / Turbio
Filancia (Viscosidad)	Alta (como clara de huevo)	Baja	Muy baja (acuoso)

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la Filancia: La viscosidad del líquido sinovial normal depende del ácido hialurónico. En procesos infecciosos e inflamatorios, las enzimas bacterianas y lisosomales de los neutrófilos degradan el hialuronato, haciendo que el líquido pierda su capacidad de formar "hilos" (filancia) y se vuelva acuoso.

- **Cocáceas Gram (+):** Sugiere *Staphylococcus aureus* (causa más frecuente en adultos).
- **Cocáceas Gram (-):** Sugiere *Neisseria gonorrhoeae* (frecuente en adultos jóvenes sexualmente activos).
- **Estudio de Cristales (Luz Polarizada):**
- **Birrefringencia Negativa (forma de aguja):** Ácido úrico (**Gota**).
- **Birrefringencia Positiva (forma romboidal):** Pirofosfato de calcio (**Condrocálcinosis**).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un líquido articular muestra **bacterias y cristales simultáneamente**, el diagnóstico que manda es la **Artritis Séptica**. La presencia de una patología de base (Gota, AR o Artrosis) es el principal factor de riesgo para desarrollar una sobreinfección bacteriana en la articulación.

Exámenes Complementarios

- Aunque la artrocentesis es el "Gold Standard", otros exámenes ayudan a orientar el cuadro:
- **Radiografía:** Útil para ver signos de condrocálcinosis (calcificación del cartílago), erosiones (sugiere AR o gota crónica) o para descartar fracturas en caso de trauma.
- **Hemograma y VHS/PCR:** Para evaluar la magnitud de la respuesta inflamatoria sistémica.
- **Niveles de Ácido Úrico:** Pueden estar elevados en gota, pero ojo: un nivel normal no descarta una crisis aguda.

Situaciones Clínicas Especiales

1. La Podagra

Es la monoartritis de la **primera articulación metatarsofalángica**. Es altamente sugerente de **Gota**. **Conducta:** Si el cuadro es clásico y no hay sospecha de infección (sin fiebre, paciente joven, antecedente de crisis previas), se podría manejar clínicamente. Sin embargo, ante la duda, siempre se debe puncionar.

2. Sospecha de Trauma o Cáncer

Si el paciente refiere un traumatismo previo o tiene antecedentes de neoplasia: 1. **Primer examen:** Radiografía (antes que la punción). 2. **Objetivo:** Descartar fractura (que causa hemartrosis) o lesiones osteolíticas/metástasis.

3. El Paciente con Artritis Reumatoide (AR)

Si un paciente con AR conocida presenta una articulación desproporcionadamente más inflamada que el resto ("articulación fuera de rango"), se debe puncionar obligatoriamente para descartar una **artritis séptica sobreagregada**.

Algoritmo de Enfrentamiento

- **Anamnesis y Examen Físico:** Confirmar que es una monoartritis (inflamación intraarticular) y no una celulitis o bursitis.
- **¿Hay sospecha de trauma o tumor?**
- Si: Solicitar Radiografía.
- No: Proceder a Artrocentesis.
- **Analizar Líquido Sinovial:**
- Si es purulento o >50.000 leucocitos → **Tratar como Artritis Séptica**.
- Si hay cristales → Tratar según el cristal (**Gota o Condrocálcinosis**).
- Si es hemorrágico → Evaluar trauma o coagulopatía.
- * Si es no inflamatorio → Evaluar artrosis o causas mecánicas.

Hallazgos Específicos en el Líquido

- **Gram y Cultivo:**

EUNACOM CRITERIOS

Regla de Oro: Ante la duda diagnóstica en una monoartritis aguda, el paciente debe ser manejado como una **Artritis Séptica** hasta que se demuestre lo contrario. El retraso en el inicio de antibióticos y drenaje puede ser catastrófico.

Resumen de Perlas para el EUNACOM

- **Artritis Séptica:** Lo más grave. Sospechar con leucocitos >50.000 y predominio PMN.
- **Gota:** Primera metatarsofalángica (**Podagra**). Cristales con birrefringencia negativa.
- **Condrocálcinosis:** Rodilla en adulto mayor. Cristales con birrefringencia positiva.
- **Artrosis:** Líquido transparente, viscoso, leucocitos <2.000.
- **Gonococo:** Sospechar en adultos jóvenes con conductas de riesgo y Gram (-) en el líquido.
- **Factor de Riesgo:** El daño articular previo (de cualquier tipo) es el riesgo #1 para infección.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 70 años con monoartritis aguda de rodilla. Se realiza artrocentesis que muestra 80.000 células, cristales de birrefringencia positiva y gram sin bacterias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Diagnóstico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las dos causas más importantes de monoartritis aguda son artritis séptica (la más grave) y artritis por cristales (la más frecuente)
- El examen clave es la punción y estudio de líquido articular
- Líquido séptico: >100.000 células, turbio, poco filante; líquido artrósico: <1.000-2.000 células, transparente, filante
- Cristales birrefringencia negativa = gota; birrefringencia positiva = condrocálcinosis
- Si coexisten bacterias y cristales, siempre gana el diagnóstico de artritis séptica
- El principal factor de riesgo para artritis séptica es tener otra patología articular de base
- Podagra (primera metatarsofalángica) sugiere gota; monoartritis de rodilla en >60 años sugiere condrocálcinosis
- Ante la duda, siempre manejar como artritis séptica

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MONOARTRITIS AGUDA: ENFRENTAMIENTO DIAGNÓSTICO)**PREGUNTA 1**

Paciente de 70 años con monoartritis aguda de rodilla. Se realiza artrocentesis que muestra 80.000 células, cristales de birrefringencia positiva y gram sin bacterias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Artritis séptica
- B)** Gota
- C)** Condrocálcinosis
- D)** Artrosis
- E)** Artritis reumatoide

PREGUNTA 2

Se punciona una articulación inflamada y el líquido muestra bacterias gram positivas y cristales de ácido úrico. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Tratar como gota exclusivamente con AINEs
- B)** Tratar como artritis séptica con antibióticos y drenaje
- C)** Tratar ambas con colchicina y antibióticos por igual
- D)** Repetir la punción en 48 horas para confirmar
- E)** Iniciar alopurinol y observar

PREGUNTA 3

¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar una artritis séptica?

- A)** Diabetes mellitus
- B)** Inmunosupresión por corticoides
- C)** Tener otra patología articular de base
- D)** Uso de drogas intravenosas
- E)** Edad mayor de 65 años

RESUMEN: MONOARTRITIS AGUDA: ENFRENTAMIENTO DIAGNÓSTICO

Esta clase aborda el enfrentamiento diagnóstico de la monoartritis aguda. Las dos causas más importantes son la artritis séptica (la más grave) y la artritis por cristales (la más frecuente, especialmente condrocalcinosis en adultos mayores y gota). En niños, la artritis séptica es la causa más frecuente. El examen más importante es la punción y estudio de líquido articular. El líquido no inflamatorio (artrosis) tiene menos de 1000-2000 células, es transparente y filante. El líquido de artritis séptica tiene más de 100.000 células, es turbio y poco filante. La artritis por cristales tiene más de 2000-5000 células. Cocáceas gram positivas indican *S. aureus*; gram negativas sugieren gonococo. Cristales de birrefringencia negativa indican gota; birrefringencia positiva indica condrocalcinosis. Si hay bacterias y cristales simultáneamente, siempre gana el diagnóstico de artritis séptica por ser lo más grave. El principal factor de riesgo para artritis séptica es tener otra patología articular de base. Ante la duda, siempre manejar como artritis séptica.